DATO DE ATENCIÓN URGENCIA (DAU)

ESTABLECIMIENTO	:	HOSPITAL SAN CARLOS	N°DAU	:	3805791
CALIDAD	:	Original	FECHA	:	29/09/2024 09:52
AREA	:	U.E. Adulto	BOX	:	Sala Hidratació
HC	:	2007314853	CTA. CTE.	:	0

DATOS CONSULTANTE:

Nombre : JUANA ALIDA MUÑOZ LAGOS **RUN** : 7.643.562-6 **CP** : 466275
Previsión : FONASA B **F.Nac** : 03/12/1955 **Género** : Femenino **Edad** : 68 Años 9 Meses 26 Días
Dirección : SAN CAMILO klm 7 // 995081759(MARIDO) **Comuna** : SAN CARLOS **Teléfono** : 995081759

DATOS INGRESO:

Procedencia : 1_EXTERIOR **Mot. Consulta** : MORBILIDAD COMUN
Lug. Ocurrencia : NO_ESPECIFICADO **Med. Llegada** : AUTO PARTICULAR

SELECTOR DEMANDA: 1° llamado: 29/09/2024 09:56:10;

Profesional : Maritza Yasmin Biernay Morales **Hra. Llamada** : 29/09/2024 09:56 **Hora Atención** : 29/09/2024 10:03
T° Axilar : 0 **T° Rectal** : **Presión** : **Pulso** : 0 **Frec. Resp.** : 0
Saturometría : 0 **HGT** : **Peso** : **Glasgow** : **Clasificación** : C2
Motivo de consulta: : ADULTO MAYOR REFIERE SENSACION DE DIFICULTAD PARA RESPIRAR, EMESIS DE UNA SEMANA DE EVOLUCION
ACOMPAÑADA
AM:DM, HTA- IAM??
ALERGIAS: NO
SAT:89-90% FC:89 LPM PA: 199/87 MMHG (MONITOR)

CONTROL SIGNOS VITALES:

Fecha	Pulso	Presión	T° Axilar	T° Rectal	FR	Sat.	HGT	Profesional
29/09/2024 10:11	86					94		VIVIANA CELEDON PINILLA
29/09/2024 12:19	80	190/90	36.6			94		Yasna Isabel Gutiérrez Faúndez

ACCIDENTE, ALCOHOLEMIA Y/O TOXICOLOGIA:

INFORME LESIONES : NO **INFORME ALCOHOLEMIA:** : NO

ANAMNESIS:

Fecha	Anamnesis	Profesional
29/09/2024 10:08	HTA, DM2, EPOC. Tabaquismo suspendido . Cardiopatía coronaria (PTCA c/BMS ACD y PTCA c/DES DA 2017). fa en taco, CRM mayo 2024, FE: 39-40% paciente consulta por dolor toracico, nauseas , vomitos disnea en reposo, sintomas de al menos 1 mes de evolucion que exacerban hace 1 dia concomitante disuria y orinas turbias	Gisbel Sanchez Rivero
29/09/2024 15:27	ANGIOTAC DE TORAX Impresión: Examen sin evidencias de tromboembolismo pulmonar. Leve derrame pleural bilateral loculado. Bandas atelectásicas bilaterales. Engrosamiento septal bilateral que puede reflejar edema intersticial. Resto señalado en el cuerpo del informe.	Gisbel Sanchez Rivero
29/09/2024 15:33	PH 7.45 PCO2 27.3 PO2 64.1 FIO2 21% PAFI= 305 mmHg	Gisbel Sanchez Rivero

EXAMEN FÍSICO :

Fecha	Examen Físico	Profesional
29/09/2024 10:08	afebril yugulares algo ingurgitadas normocardica hipertensa rr2t ss mp+ con crepitos bilaterales en bases, uma- abdomen blando depresible sensible en hipogastrio blumberg- rha+ eeii con edema+ neurologico sin focalidad	Gisbel Sanchez Rivero

DIAGNÓSTICOS: **Condición de ingreso:** Conciente

Fecha	Hipótesis diagnóstica	Profesional
29/09/2024 13:03	ICC	Gisbel Sanchez Rivero
29/09/2024 13:03	N39.0 INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	Gisbel Sanchez Rivero

PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y/O TERAPÉUTICOS (TRATAMIENTO EN BOX):

Fecha	Procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos	Profesional	Estado	Responsable
29/09/2024 10:22	tomar ecg	Gisbel Sanchez Rivero	Ejecutado el 29/09/2024 10:49	Makarena Fuentes Torres Obs:Realizado interna enfermería
29/09/2024 10:23	examenes de lab	Gisbel Sanchez Rivero	Ejecutado el 29/09/2024 11:31	Viviana Sanchez Zuñiga
29/09/2024 10:23	ondansetron 8mg ev	Gisbel Sanchez Rivero	Ejecutado el 29/09/2024 11:32	Viviana Sanchez Zuñiga
29/09/2024 10:23	furosemida 1 amp ev	Gisbel Sanchez Rivero	Ejecutado el 29/09/2024 15:54	VIVIANA CELEDON PINILLA
29/09/2024 10:23	hidrocortisona 300mg ev	Gisbel Sanchez Rivero	Ejecutado el 29/09/2024 11:32	Viviana Sanchez Zuñiga
29/09/2024 10:25	bromuro de ipratropio 2 puff cada 15 min por 3 veces	Gisbel Sanchez Rivero	Ejecutado el 29/09/2024 10:34	VIVIANA CELEDON PINILLA
29/09/2024 13:02	Ceftriaxona 2 gr ev	Gisbel Sanchez Rivero	Ejecutado el 29/09/2024 14:38	Maritza Yasmin Biernay Morales

EXAMENES:

Fecha	Examen	Profesional
29/09/2024 10:23	RCTO GLOBULAR ; GLICEMIA ; UREMIA ; CREATININEMIA ; CK TOTAL ; CK-MB ; E.L.P. ; PCR ; ORINA COMPLETA ; PROTROMBINA ; TTPK ; INR ; GASES ARTERIALES ; AC. LACTICO ; TROPONINA I ;	Gisbel Sanchez Rivero
29/09/2024 13:03	ANGIOTC. DE TORAX	Gisbel Sanchez Rivero

INDICACIONES ALTA:

Fecha	Indicación	Profesional

29/09/2024 15:50	HOSPITALIZAR EN HODOM CEFTRIAXONA 2 GR EV CADA 24 HORAS POR 7 DIAS FUROSEMIDA TAB 40MG: 1 COMP CADA 12 HORAS VO POR 5 DIAS METOCLOPRAMIDA 10MG: 1 COMP CADA 8 HORAS POR 3 DIAS SOS NAUSEAS O VOMITOS PARACETAMOL 500MG: 2 COMP CADA 6 HORAS POR 3 DIAS FERRANIM :1 COMP VO EN LA MAÑANA POR 3 MESES RESCATAR UROCULTIVO EN 72 HORAS CONTROL EN URGENCIAS SOS SIGNOS DE ALARMA SE ENTREGA INFORMACION A ESPOSO	Gisbel Sanchez Rivero

RECETAS:

Fecha	Prescripción	Profesional
29/09/2024 15:49	CEFTRIAXONA 2 GR EV CADA 24 HORAS POR 7 DIAS FUROSEMIDA TAB 40MG: 1 COMP CADA 12 HORAS VO POR 5 DIAS METOCLOPRAMIDA 10MG: 1 COMP CADA 8 HORAS POR 3 DIAS SOS NAUSEAS O VOMITOS PARACETAMOL 500MG: 2 COMP CADA 6 HORAS POR 3 DIAS FERRANIM :1 COMP VO EN LA MAÑANA POR 3 MESES	Gisbel Sanchez Rivero

OBSERVACIONES:

Fecha	Indicación	Profesional
29/09/2024 10:50	Se toma ECG y se presenta a medico solicitante Realizado interna enfermería	Makarena Fuentes Torres
29/09/2024 11:32	INSTALO VVP ·18 ESD 1 INTENTO + ADMIN TTO SIM L+ TOMO GASES ARTERIALES BRAQUIAL DERECHA	Viviana Sanchez Zuñiga

GES : No **PERTINENCIA** : Si **DESTINO** : Domicilio

ADVERTENCIA
ESTE ES UN DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO Y SÓLO UNA PRIMERA ATENCIÓN. DEBE CONSULTAR A SU CENTRO DE SALUD O MÉDICO TRATANTE DENTRO DE LAS 12-24 HORAS SIGUIENTES. SI SUS SÍNTOMAS EMPEORAN, CONSULTE NUEVAMENTE A LA BREVEDAD. ES SU RESPONSABILIDAD SEGUIR ESTAS INDICACIONES.

LLAME A SALUD RESPONDE
600·360·7777
PROFESIONALES DE LA SALUD ATENDIENDO SUS DUDAS LAS 24 HORAS, LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA

Gisbel Sanchez Rivero
26.978.181-5